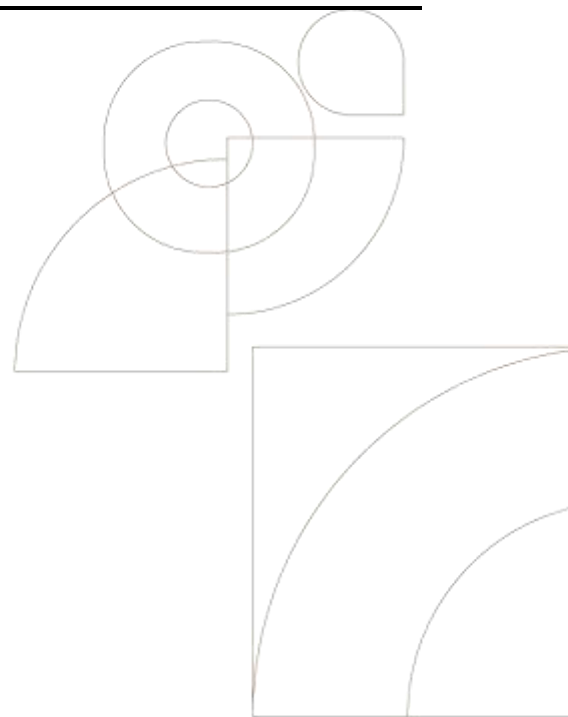

MANUAL METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RIAS VIGENCIA



ELABORADO POR:
Claudia Marcela Orduy Forero
Contratista de secretaria de salud.
Dirección de aseguramiento y prestación de servicios.

Tabla de contenido

Introducción..... 2

Objetivo general..... 2

Objetivos específicos..... 2

Contexto y necesidad del instrumento..... 2

Contexto Actual en Zipaquirá..... 2

Importancia del Instrumento..... 3

Marco normativo..... 3

Relevancia..... 3

Alcance del manual..... 4

Marco Conceptual..... 5

Importancia de las RIAS..... 6

Componentes clave..... 7

Contexto Normativo y Político en Zipaquirá..... 8

Marco Normativo..... 8

Oportunidades contexto normativo - político..... 9

Descripción del Instrumento de vigilancia..... 9

Fase de diagnóstico..... 9

Funciones específicas..... 10

Aplicación del instrumento..... 11

Rutas evaluadas..... 11

Estructura del instrumento..... 13

Adherencia Listas de chequeo..... 15

Fase de seguimiento..... 16

Metodología..... 17

Alerta inmediatas a reportar 17

Alcances del seguimiento líneas..... 17

Diseño metodológico..... 18

Evaluación y seguimiento continuo..... 20

Conclusiones y recomendaciones..... 21

Anexos..... 22

Cronograma RIAS..... 22

Glosario de términos..... 23

Bibliografía..... 24

Introducción.

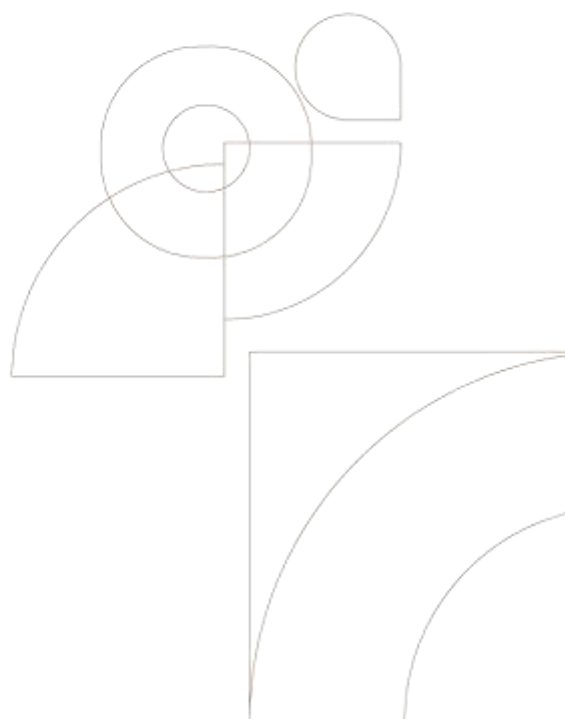
La implementación efectiva de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) es fundamental para garantizar una atención integral, equitativa y centrada en el curso de vida de la población del municipio de Zipaquirá. En el marco de la política de salud del país y del municipio, las RIAS se constituyen como una estrategia clave para mejorar la calidad de la atención en salud y promover la salud y el bienestar de la población.

En este sentido, el presente manual metodológico se constituye como un instrumento técnico esencial para estandarizar procesos tanto administrativos como asistenciales los cuales fortalecerá, la adherencia a las rutas integrales en salud y mejorar la calidad de la atención en salud. El objetivo de este manual es proporcionar una guía clara y concisa para la implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS en el municipio de Zipaquirá, asegurando que los profesionales de la salud y los prestadores primarios de la atención en salud, cuenten con los lineamientos e instrumentos necesarios para brindar una atención integral y de alta calidad.

A través de este manual, se busca promover una cultura de calidad y excelencia en la atención en salud, que se centre en las necesidades y expectativas de la población, y que contribuya a mejorar los indicadores de salud y bienestar en el municipio.

Con este manual la Secretaría de Salud del municipio de Zipaquirá, en su compromiso de garantizar una atención integral, equitativa y centrada en el curso de vida de la población, ha desarrollado esta guía para orientar a los colaboradores en la aplicación de los instrumentos de vigilancia y seguimiento a instituciones prestadoras de servicios de salud en la implementación de las Rutas Integrales en Salud (RIAS).

Finalmente este manual metodológico se desarrollará en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio de Zipaquirá que implementen las RIAS, con el fin de obtener resultados frente al mantenimiento de los indicadores de las rutas integrales en salud de la jurisdicción.



SC-CER587218



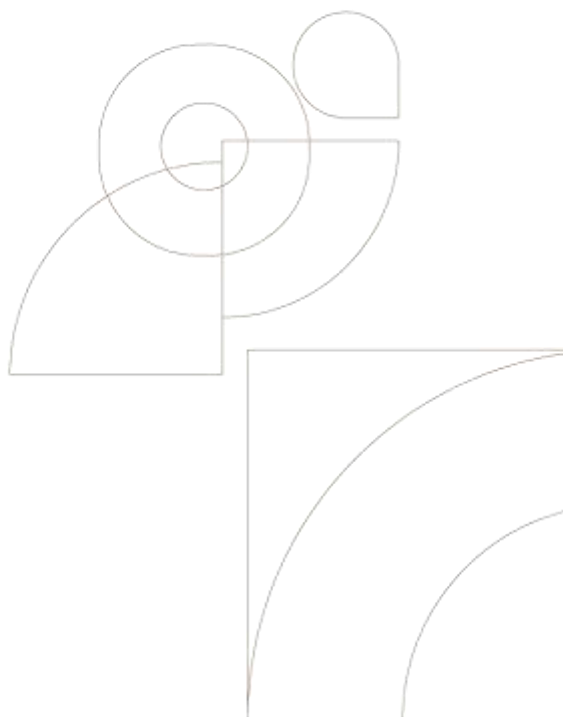
Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Objetivo general

Brindar una guía que oriente a los colaboradores de la secretaría de salud para la aplicación de los instrumentos de vigilancia y seguimiento a instituciones prestadoras de servicios de salud en la implementación de las rutas integrales en salud (RIAS)

Objetivos específicos:

- Facilitar la implementación metodológicas para el uso adecuado a los instrumentos a desarrollar en las IPS del municipio de Zipaquirá.
- Fortalecer la adherencia de las rutas integrales de atención en salud, garantizando que las IPS del municipio tengan una calidad y cobertura efectivas frente a la prestación de los servicios.
- Seguimiento de los instrumentos implementados en la estrategia RIAS, con el fin de tener análisis constante de datos, y a su vez tener identificado las oportunidades de mejoras para poder trabajar en estas mismas.
- Proporcionar resultados confiables que aporten a generar estrategias que impacten los indicadores de la resolución 3280 en la plataforma sigires de las EPS -IPS que hacen presencia en la jurisdicción, lo que generara un impacto positivo a la salud pública del municipio.



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Contexto y Necesidad del Instrumento

En el ámbito de la salud pública, es esencial diseñar e implementar instrumentos de vigilancia para hacer frente a las exigencias y retos que presenta el sistema general de seguridad social en salud, en donde la supervisión de las RIAS especialmente en la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud por cada curso de vida, y la ruta Materno Perinatal, son el enfoque esencial de la atención primaria en salud, es por esto que se desarrollara unos instrumento esencial que aportaran al seguimiento continuo de la adherencia de estas mismas frente al acceso de los servicios en salud de la población Zipaquireña.

Contexto Actual en Zipaquirá

Zipaquirá cuenta con nueve IPS municipales que ofrecen atención primaria en salud es por ello que surge la implementación de la estrategia RIAS por parte de Secretaria de salud, dando una respuesta a la necesidad de los ciudadanos del municipio con el fin de mejorar la calidad, continuidad y equidad en la atención, mediante los instrumentos que permitan evaluar el cumplimiento, identificar brechas y orientar acciones correctivas

Importancia del Instrumento:

El instrumento de vigilancia es fundamental porque:

1. **Proporciona datos clave:** permite el seguimiento detallado de la adherencia a las rutas, identificando fallas y áreas de mejora.
2. **Facilita la evaluación de impacto:** mide cómo las intervenciones contribuyen a mejorar los indicadores de salud pública.
3. **Promueve la equidad:** identifica desigualdades en la prestación de servicios y orienta recursos hacia las poblaciones más vulnerables.
4. **Fortalece la toma de decisiones:** ofrece información confiable para la planificación estratégica y asignación de recursos.

Relevancia en el Marco Normativo

La implementación de este instrumento está alineada con las políticas nacionales de salud y con los objetivos establecidos en los planes locales de desarrollo, contribuyendo a:

- Cumplir con los estándares de calidad definidos por el Ministerio de Salud.
- Monitorear el impacto de los programas en salud pública.
- Garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de servicios esenciales.

Es por esto que este manual no solo responde a una necesidad técnica, sino que constituye una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zipaquirá, contribuyendo a la construcción de un sistema de salud más inclusivo, eficiente y centrado en las personas y su ciclo de vida.

Importancia de las Rutas Integrales de Atención

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) constituyen un enfoque estratégico dentro del sistema de salud para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la atención brindada a los usuarios. Estas rutas están diseñadas para articular los diferentes niveles de atención en salud, promoviendo la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y la rehabilitación oportuna de los pacientes.(2)

Beneficios de las Rutas Integrales de Atención

1. **Atención Centrada en el Usuario:** las RIAS garantizan que las necesidades del usuario sean el eje central, evitando fragmentaciones y duplicidades en los servicios.



SC-CER587218



Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

2. **Promoción de la Equidad:** facilitan el acceso equitativo a servicios de calidad, particularmente para poblaciones vulnerables.
3. **Optimización de Recursos:** aseguran el uso eficiente de los recursos disponibles, reduciendo costos innecesarios y mejorando los resultados en salud.
4. **Mejora en Indicadores de Salud Pública:** contribuyen a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a condiciones prevenibles y manejables dentro del sistema.

Enfoque en la Población Materno Perinatal y de Promoción y Mantenimiento de la Salud

En Zipaquirá, las RIAS tienen un papel fundamental en dos campos esenciales:

- **Población Materno Perinatal:** contribuyen a que las mujeres reciban atención integral durante la gestación, el parto y el posparto, además de los recién nacidos, previniendo así complicaciones y fomentando un desarrollo sano.
- **Promoción y Mantenimiento de la Salud:** promueven la prevención de enfermedades y estilos de vida saludables mediante acciones sostenibles y coordinadas.

Rol en la Vigilancia y Evaluación

Las RIAS proporcionan un marco estructurado para la vigilancia y evaluación del desempeño del sistema de salud, permitiendo:

- Identificar brechas en la atención y diseñar estrategias correctivas.
- Establecer estándares de calidad medibles.
- Promover la integración de datos entre instituciones para decisiones basadas en evidencia.

En de resaltar que las Rutas Integrales de Atención son un pilar fundamental para garantizar un sistema de salud efectivo, equitativo y sostenible, impactando positivamente en la calidad de vida de la población y en los indicadores de salud pública del municipio de Zipaquirá.

Alcance del Manual

El alcance de este manual está enfocado en la implementación adecuada, monitoreo y evaluación de los instrumentos elaborados por la secretaria de salud para la vigilancia en el seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) en el municipio de Zipaquirá.

Cobertura Geográfica

Este manual se desarrollará en las (IPS) del municipio de Zipaquirá, garantizando que las acciones de vigilancia se adapten a las necesidades y características de la población local.

Población Objetiva

El manual está dirigido a:

- Personal de secretaria de salud encargado de implementar y supervisar el instrumento.
- Personal administrativo como directores, coordinadores y líderes de los programas de promoción y detección de las IPS que operan en la jurisdicción frente a la prestación de los servicios de salud, con el fin de obtener planeaciones estratégicas frente a la cobertura de indicadores establecidos en la plataforma SIGIRES que hacen referencia al comportamiento de estos frente a PYD
- Equipos técnico de secretaria de salud encargados de la recopilación, análisis y reporte de datos relacionados con la adherencia a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

Alcance Funcional

El manual abarca los siguientes aspectos:



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

1. **Implementación del Instrumento:**

- ✓ Metodología para la aplicación efectiva en el campo.
- ✓ Instrumentos y recursos necesarios.

2. **Monitoreo y Evaluación:**

- ✓ Indicadores clave para medir la adherencia y coberturas
- ✓ Procedimientos para ajustes y retroalimentación continua.

3. **Capacitación y Sensibilización:**

- ✓ Lineamientos para la formación de personal.
- ✓ Estrategias para sensibilizar a las IPS sobre la importancia de la adherencia al 100% de las RIAS.

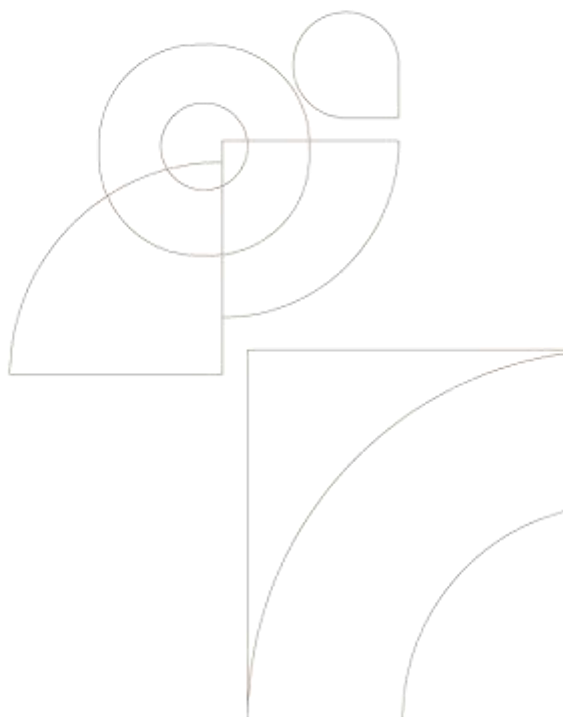
Limitaciones

El manual se enfoca exclusivamente en las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la atención materno perinatal. No incluye otros componentes del sistema de salud que no estén directamente relacionados con estas rutas.

Este manual establece un marco claro y práctico para garantizar que las acciones de vigilancia se lleven a cabo de manera uniforme, eficiente y alineada con los objetivos de salud pública del municipio de Zipaquirá.

Principios clave

- Integralidad
- Continuidad
- Accesibilidad
- Equidad
- Enfoque diferencial



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Marco Conceptual

Definición de Rutas Integrales de Atención en Salud

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) son tácticas organizativas y operativas creadas para asegurar que las personas accedan, durante toda su vida, a una atención sanitaria continua, integral y de alta calidad. Estas rutas reúnen las acciones requeridas para prevenir, diagnosticar, tratar y restablecer la salud en los diversos niveles de atención, garantizando la coordinación entre los participantes del sistema de salud.

Principios de las RIAS

1. **Integralidad:** las RIAS incorporan medidas preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras y de promoción de la salud, garantizando que las necesidades de los individuos se traten integralmente.
2. **Continuidad:** las intervenciones se llevan a cabo de manera coordinada para asegurar una transición sin problemas entre los distintos niveles y servicios de atención.
3. **Accesibilidad:** con el objetivo de eliminar obstáculos económicos, geográficos, administrativos y culturales que impidan el acceso a los servicios sanitarios, se crean las rutas.
4. **Enfoque en el ciclo de vida:** se tienen en cuenta las necesidades particulares de salud a lo largo de todas las etapas de la vida, desde el embarazo hasta la vejez.
5. **Equidad:** para minimizar las desigualdades en salud, se da prioridad en la atención a las poblaciones vulnerables.

Componentes de las RIAS

1. **Gestores de las rutas:** los actores encargados de planear, organizar y supervisar el despliegue de las rutas.
2. **Prestadores de Servicios de Salud:** IPS responsables de asegurar que se brinden los servicios en cada punto de atención.
3. **Usuarios del Sistema de Salud:** usuarios de los servicios, a quienes se les debe proporcionar información y orientación para que utilicen las rutas correctamente.
4. **Indicadores de Seguimiento:** basados en el reporte mensual que cada prestador realiza en la plataforma nacional del SIGIRES la cual hace referencia a los indicadores del PYD según la resolución 3280 de 2019, debe tener un monitoreo constante el líder de gestión del riesgo y gestión clínica de la IPS-EPS ya que estos son los garantes de la población afiliada en el Municipio y debe asegurar la gestión del riesgo tanto individual como grupal del usuario.

Importancia de las RIAS

Para asegurar un sistema de salud enfocado en el ser humano, que responda eficazmente a las necesidades de la población, impulse la prevención de enfermedades y promueva el bienestar general, son esenciales las RIAS. En el marco de Zipaquirá, su aplicación ayuda a optimizar los indicadores de salud pública y a reforzar la capacidad del sistema para responder a las necesidades locales.

Adherencia a las Rutas y su Impacto en Salud Pública

Para asegurar la eficacia de las intervenciones en salud pública, es imprescindible que se cumplan las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). De esta manera se brinda una atención más equitativa, eficaz y centrada en las necesidades de la población cuando los profesionales del sector y las instituciones que brindan servicios de salud (IPS) acatan estrictamente las RIAS.

Impacto en la Salud Pública:

1. **Mejora en los resultados de salud:**



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

- La implementación exitosa de las RIAS ayuda a disminuir la prevalencia y la incidencia de enfermedades que son prevenibles.
- Promueve el diagnóstico precoz y la gestión a tiempo de condiciones crónicas y agudas.

2. Optimización de recursos:

- Se previene el empleo innecesario de recursos y la duplicación de esfuerzos al estandarizar los procedimientos y priorizar las intervenciones sustentadas en evidencia.
- Se optimiza la distribución y planificación de los presupuestos relacionados con la salud.

3. Reducción de inequidades:

- Las RIAS fomentan que todos los individuos tengan acceso a servicios de salud, sin importar su nivel socioeconómico o la localización geográfica.
- Ayudan a cerrar las disparidades en la atención a grupos vulnerables.

4. Fortalecimiento del sistema de salud:

La atención integrada y estructurada permite que el sistema tenga una mejor capacidad de reacción ante retos nuevos, como cambios demográficos o brotes epidémicos.

5. Empoderamiento de la comunidad:

El cumplimiento de las RIAS estimula la educación en salud y el autocuidado, lo que hace que un número mayor de personas participe en actividades en salud frente a su bienestar.

Desafíos en la Adherencia:

- **Capacitación y sensibilización:** es indispensable que los profesionales de la salud entiendan y apliquen las RIAS en su práctica cotidiana.
- **Seguimiento y monitoreo:** la falta de mecanismos sólidos para evaluar la observancia de las RIAS podría restringir su impacto.
- **Barreras estructurales:** la implementación apropiada de las RIAS puede verse afectada por factores como la escasez de recursos, la dispersión geográfica y la infraestructura limitada.

Para superar estos retos en Zipaquirá, es necesario que las IPS, la Secretaría de Salud y la comunidad trabajen juntas como aliados estratégicos que lleven a cumplir con las RIAS, buscando no solo optimizar los indicadores de PYD, sino que además fortalece la confianza en el sistema y favorece una adherencia a los servicios de salud.

Componentes Clave de las Rutas Integrales

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) se organizan en elementos esenciales que garantizan su eficacia y adecuación a las necesidades de la población. Estos elementos posibilitan que las intervenciones en salud se organicen de manera sistemática, asegurando así una atención continua e integral. Se describen a continuación los componentes más importantes:

1. Promoción de la Salud

Este componente incluye las acciones que buscan optimizar el bienestar general de la población, promoviendo modos de vida saludables y empoderando a las comunidades para que manejen su salud.

2. Prevención de Enfermedades

Incorpora acciones enfocadas en prevenir la aparición de enfermedades a través de intervenciones oportunas y eficaces.

3. Atención Integral



SC-CER587218



Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Garantiza que los servicios sean ininterrumpidos y estén coordinados a través de los diversos niveles de atención, desde la promoción hasta la rehabilitación.

4. Intersectorialidad

Supone la cooperación entre áreas como medio ambiente, desarrollo social y educación para tratar los factores sociales que determinan la salud.

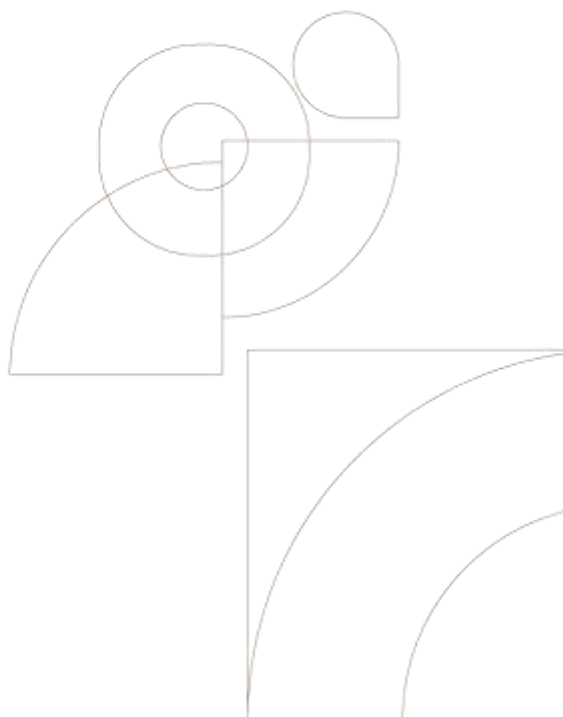
5. Enfoque Diferencial

Identifica y ajusta las intervenciones a los rasgos y requerimientos particulares de grupos poblacionales como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y comunidades étnicas.

6. Monitoreo y Evaluación

Implementa sistemas para calcular la puesta en marcha y el efecto de las rutas, garantizando modificaciones constantes para optimizar su eficacia.

Estos componentes trabajan en conjunto para asegurar que las RIAS sean instrumentos eficaces en el perfeccionamiento de los resultados en salud pública, estos elementos colaboran entre sí, fomentando la disponibilidad igualitaria a servicios de calidad y robusteciendo la habilidad del sistema sanitario para satisfacer las demandas de la población.



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Contexto Normativo y Político en Zipaquirá

Para entender cómo los sistemas de salud pública funcionan y se implementan en Zipaquirá, es crucial tener en cuenta el entorno político y normativo, sobre todo cuando se trata de implementar estrategias e intervenciones que busquen promover la salud y garantizar que todos tengan acceso a servicios de atención. En este marco se establecen los lineamientos, las políticas, las regulaciones y los métodos de intervención que guían la planificación, la implementación y el seguimiento de las acciones en salud pública a nivel municipal.

Marco Normativo

Las medidas de salud pública en Zipaquirá se alinean con las normas nacionales e internacionales, y cumplen con los lineamientos establecidos por el sistema sanitario colombiano y la Organización Mundial de la Salud (OMS)(3). Estas pautas engloban el establecimiento de políticas y estrategias destinadas a asegurar la equidad, el acceso oportuno, la calidad del servicio y el involucramiento de la comunidad en la administración de su salud.

Algunas de las principales regulaciones incluyen:

- **Plan Nacional de Desarrollo:** instrumento que define las prioridades gubernamentales para tratar las desigualdades en el ámbito de la salud y asegurar que los servicios estén disponibles.
- **Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS):** marco regulador de la oferta de servicios sanitarios en el país.
- **Normas de Atención Primaria en Salud (APS):** lineamientos para asegurar la asistencia comunitaria, preventiva y a tiempo.
- **Políticas de Atención Materno Perinatal y Equidad en Salud:** estrategias centradas en cuidar a colectivos vulnerables, sobre todo a la población materna y perinatal.

Contexto Político Local.

En Zipaquirá, el ámbito político tiene un rol fundamental en la planificación y realización de las actividades relacionadas con la salud pública. Las autoridades municipales, trabajando en conjunto con el gobierno departamental y nacional, elaboran políticas públicas que se ajustan a las necesidades específicas de la región. Estos esfuerzos abarcan:

- **Desarrollo de estrategias de inclusión:** mejorar el acceso a los servicios sanitarios para colectivos vulnerables, como son las mujeres embarazadas, la población indígena, los adultos mayores y las personas que viven en condiciones de pobreza.
- **Fortalecimiento de la infraestructura en salud:** el desarrollo de centros de atención primaria y la optimización de las habilidades de atención en los servicios sanitarios.
- **Participación ciudadana en la gobernanza:** promover la participación activa de la comunidad en el diseño de intervenciones en salud pública.

Desafíos en el Contexto Normativo y Político

La implementación de las políticas públicas en el ámbito local de Zipaquirá se enfrenta a ciertos retos:

1. **Desigualdades en el acceso a servicios:** aunque se han hecho esfuerzos normativos, sigue siendo un obstáculo significativo la desigualdad en el acceso a los servicios de salud.
2. **Recursos limitados:** la disponibilidad de insumos médicos, infraestructura y personal preparado para satisfacer las necesidades de la población se ve impactada por las limitaciones presupuestarias.
3. **Coordinación interinstitucional:** puede haber problemas para implementar las estrategias si no hay coordinación entre las instituciones nacionales, regionales y locales.
4. **Participación comunitaria:** continuar garantizando que la comunidad participe activamente en los procesos de planificación y toma de decisiones sigue siendo una tarea por completar.



SC-CER587218



Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

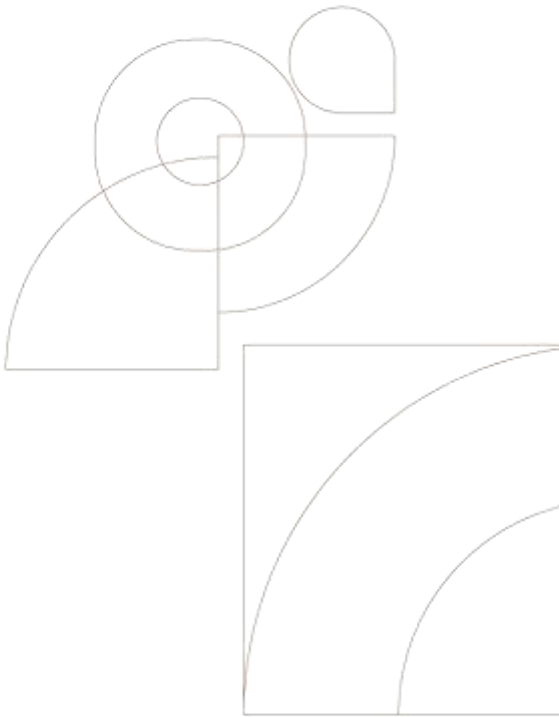


Oportunidades en el Contexto Normativo y Político

Aunque hay desafíos, el marco político y normativo de Zipaquirá también brinda posibilidades de mejorar la atención sanitaria a través de:

- **Estrategias integrales de colaboración:** la cooperación entre las distintas entidades e intersectorial puede robustecer la respuesta a las demandas sanitarias de la población.
- **Políticas públicas orientadas a la equidad:** la puesta en marcha de políticas que incluyan a los grupos vulnerables y que tengan un enfoque centrado en ellos puede ayudar a reducir las desigualdades en la atención sanitaria.
- **Fomento de la educación en salud:** mediante la normativa, se pueden poner en marcha estrategias de prevención y promoción con el objetivo de empoderar a las personas para que cuiden de su salud.

Para entender la implementación de estrategias de salud pública y el uso de los instrumentos de seguimiento en la adhesión a rutas integrales de atención en salud (RIAS), es fundamental tener en cuenta el contexto normativo y político en Zipaquirá, con el fin de afrontar los desafíos en la salud pública y asegurar que los indicadores de salud del municipio sigan mejorando, es esencial desarrollar políticas fundamentadas en pruebas, fortalecer las instituciones, garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud y fomentar la participación de la comunidad.



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Descripción del Instrumento de Vigilancia.

Objetivo y Función del Instrumento

El objetivo principal del instrumento de supervisión elaborado por la Secretaría de Salud de Zipaquirá es hacer seguimiento, análisis y evaluación del cumplimiento efectivo de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Estos instrumentos posibilitan la sistematización de datos acerca de la calidad, la cobertura y la oportunidad de los servicios ofrecidos, lo cual ayuda a tomar decisiones fundamentadas en evidencia.

Objetivos específicos del Instrumento

1. Comprobar que se cumplan los estándares de calidad establecidos en las rutas de atención.
2. Detectar diferencias en la provisión de servicios, tanto en términos de cobertura como de oportunidad.
3. Producir datos confiables para dirigir las estrategias de intervención y las políticas públicas.
4. Apoyar la consecución de objetivos en salud pública, reforzando la atención integral en salud

Funciones específicas del Instrumento

Este instrumento aporta como estrategia, evidenciar la adherencia a las rutas integrales en salud por cada curso de vida, disminuir barreras de acceso frente a la prestación de los servicios y fortalecer a la población para promover su salud y prevenir la enfermedad.

1. **Recolección sistemática de datos:** posibilita el obtener información tanto cualitativa como cuantitativa en relación con la asistencia y los servicios suministrados por las IPS.
2. **Seguimiento continuo de los servicios de salud:** permite la supervisión continua para reconocer tendencias, patrones y potenciales aspectos de intervención.
3. **Análisis e interpretación de la información:** el instrumento, basado en la información recolectada, es capaz de detectar factores decisivos, obstáculos y fortalezas en la atención que ofrecen las IPS.
4. **Retroalimentación para la mejora continua:** ofrece a las IPS y a los organismos responsables sugerencias concretas que posibilitan la adecuación, rectificación o mejora de la calidad del servicio.
5. **Evaluación del impacto de las intervenciones en salud pública:** permite establecer si la estrategia empleada está generando los resultados deseados con respecto a la calidad de atención, la cobertura y el bienestar de la población.

Fase de diagnóstico

El instrumento se compone de listas de verificación que generan un resultado frente a la adherencia a historia clínica y listas de chequeo según cohortes priorizadas desde las líneas de salud pública, los cuales están organizados por ruta materno perinatal y promoción y mantenimiento de la salud por su curso de vida. Su implementación se lleva a cabo por fases las cuales tienen una primera fase que corresponden a un diagnóstico en el cual se da a conocer el modelo de atención que opera la IPS de atención primaria frente al manejo de las rutas integrales en salud, en donde se puede observar aspectos a mejorar, la segunda fase hace referencia a seguimientos de las evidencias encontradas en pro de mejorar, bajo la vigilancia del equipo RIAS de la Secretaría de Salud.



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co



Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Procedimiento de Aplicación del Instrumento

El proceso de implementación del instrumento se realizará de acuerdo con los siguientes procedimientos:

Diseño y Planificación

El equipo RIAS diseño instrumentos con los componentes y aspectos a evaluar, de las rutas priorizadas ya mencionadas y su respectivo curso de vida, este instrumento está debidamente organizado secuencialmente, bajo la normatividad establecida por la Resolución 3280 de 2019.

Evaluación del instrumento de adherencia a historia clínica y listas de chequeo

Se lleva a cabo el análisis de 8 a 10 historias clínicas por cada curso de vida de la ruta materno perinatal y promoción y mantenimiento de salud de cada IPS, las cuales fueron elegidas aleatoriamente, es importante mencionar que se durante un ejercicio realizado en conjunto con el área de epidemiología de secretaria de salud se estable la muestra de historias clínicas por EPS con su respectiva IPS de la siguiente manera:

- EPS COOSALUD:** 8 historias clínicas, un total de 80 historias clínicas
- EPS COMPENAR:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- EPS FAMISANAR:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- EPS SURA:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- EPS SANITAS:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- EPS NUEV EPS:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- EPS SALUD TOTAL:** 10 historias clínicas, un total de 100 historias clínicas
- SANIDAD POLICIA:** 8 historias clínicas, un total de 80 historias clínicas.
- MAGUISTERIO:** 8 historias clínicas, un total de 80 historias clínicas

Posteriormente se diligencia el instrumento de adherencia a historia clínica en donde se valida el diligenciamiento, diagnósticos ,ordenamiento, interconsultas, planes educativos entre otros, es importante resaltar que para desarrollo de esta actividad se tiene presente la siguiente normativa.

1. **Resolución 1995 de 1999:**

- Define la historia clínica como un instrumento obligatorio y privado que registra de manera cronológica los datos relacionados con el estado de salud del paciente y las actuaciones realizadas por los profesionales de la salud.(4)
- Establece los principios de **confidencialidad, reserva, disponibilidad y veracidad**, que deben guiar su manejo.
- Especifica los contenidos mínimos que debe incluir, como antecedentes, diagnóstico, tratamiento y evolución clínica.

2. **Ley 23 de 1981** (Código de Ética Médica):

- Señala que la historia clínica es propiedad del paciente, aunque su custodia corresponde a las instituciones prestadoras de servicios de salud.(5)
- Reitera la obligación de garantizar la confidencialidad de la información.

3. **Ley 1581 de 2012** (Protección de Datos Personales):

- Refuerza la protección de los datos sensibles contenidos en la historia clínica, asegurando que su tratamiento se realice con el consentimiento informado del paciente.(6)

4. **Resolución 839 de 2017:**

- Regula las RIAS, estableciendo la importancia de documentar en las historias clínicas el cumplimiento de las actividades, intervenciones y servicios descritos en cada ruta.(7)

5. **Decreto 1011 de 2006:**

- Incluye la historia clínica como parte del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, resaltando su papel en la auditoría de procesos y resultados.(8)

Criterios de evaluación:

- Completitud de los registros clínicos.
- Pertinencia de las intervenciones realizadas.
- Continuidad y oportunidad en la atención.
- Evidencia de aplicación de las rutas según ciclo de vida.

 Consolidación de resultados

Se elabora un informe técnico que incluye resultado de la adherencia de cada instrumento empleado, análisis del comportamiento de los indicadores cargados en la plataforma del sigires según el periodo que se desea validar, se plasman las evidencias encontradas en el instrumento de plan de mejora, con el fin de ser trabajadas por cada prestador primario.

 Custodia y cierre de datos

Una vez que el informe ha sido terminado, el equipo RIAS de la Secretaría de Salud realiza entrega al personal administrativo del área de PYD de la IPS, asegurando la confidencialidad de los datos suministrados por ellos mismos durante las visitas establecidas, con el fin de que estos actores puedan trabajar en las evidencias encontradas desde la estrategia RIAS, que les aportara a subsanar y ejecutar mejoras en beneficios de mantener una cobertura positiva frente a las rutas integrales en salud de su población afiliada.

Metodología de Evaluación.

Criterios de calificación según el instrumento de evaluación empleado:



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Etapas	Actividad	Instrumentos	Criterios de evaluación
1. Adherencia a historia clínica	Revisión de 8 a 10 historias clínicas por IPS	Instrumento de adherencia	Satisfactorio (85–100%), Aceptable (70–84%), Crítico (50–69%), Muy crítico (≤50%)
2. Análisis de indicadores	Revisión de datos cargados en SIGRES	Plataforma SIGRES	Óptimo (90–100%), Deficiente (80–89%), Muy deficiente (60–79%), No aceptable (<60%), No reportó (0%), No aplica (N/A)
3. Verificación operativa	Aplicación de listas de chequeo por líderes PyD	Listas de chequeo por curso de vida	Satisfactorio (85–100%), Aceptable (70–84%), Crítico (50–69%), Muy crítico (≤50%)
4. Consolidado final	Generación de informe técnico	Informe de visita	Diagnóstico institucional + plan de mejora

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Rutas integrales evaluadas

Es importante tener en cuenta que la Resolución 3280 de 2018 (9), emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, establece las **rutas integrales de atención en salud (RIAS)** como un instrumento para garantizar el derecho a la salud de manera integral. Estas rutas están diseñadas para responder a las necesidades específicas de la población en diferentes momentos del curso de vida y ante diversas situaciones de salud.

Principales rutas de atención definidas en la resolución:

1. Ruta Integral de Atención para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud

○ Promueve estilos de vida saludables y previene enfermedades.
2. Rutas Integrales de Atención en Salud para Poblaciones Específicas

○ Incluye:

▪ Primera infancia.

▪ Infancia.

▪ Adolescencia.

▪ Juventud.

▪ Adultez.

▪ Vejez.
3. Rutas Integrales de Atención para las Condiciones Prioritarias de Salud

○ Cubren condiciones como:

▪ Enfermedades cardiovasculares.

▪ Cáncer.

▪ Diabetes.

▪ Salud mental.

▪ Salud sexual y reproductiva.

▪ Enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- 

SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Página 16 de 32

4. **Ruta Integral de Atención en Salud para las Emergencias**
- Establece los lineamientos para responder de manera oportuna y eficiente a emergencias en salud.
5. **Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal**
- Enfocada en garantizar la salud de la madre y el recién nacido durante el embarazo, parto y puerperio.

Estas rutas buscan la coordinación intersectorial y un enfoque centrado en el usuario para ofrecer servicios de salud equitativos, eficientes y de calidad.

De esta manera se logra iniciar con la caracterización de pacientes según la distribución poblacional por EPS-IPS que hace presencia en el municipio para evidenciar en qué ciclo de vida se encuentran y cómo intervenir a los pacientes, buscando así una adherencia de la estrategia RIAS, en donde se quiere impactar de manera positiva los indicadores de la resolución 3280, publicados en la plataforma sigires de cada EPS e IPS, a continuación se muestra el número de usuarios asignados por cada EAPB, que hace presencia en el municipio.

EPS	0-5 AÑOS	6-11 AÑOS	12-18 AÑOS	19-26 AÑOS	27-59 AÑOS	60 AÑOS +	TOTAL AFILIADOS
FAMISANAR	1,951	2,573	3,284	4,782	15,874	5,035	33,499
NUEVA EPS	1,570	1,759	1,940	3,699	9,611	5,044	23,623
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	0	3	0	5	99	107
EPS SANITAS	1,573	2,228	2,862	3,087	13,024	3,406	26,180
COOSALUD EPS-S	288	352	351	363	1,170	315	2,839
SALUD TOTAL EPS S.A.	1,922	2,648	3,044	4,073	11,529	2,209	25,425
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	0	0	0	3	2	0	5
COMPENSAR EPS	1,228	1,856	2,182	2,697	10,964	3,287	22,214
EPS SURA	2,251	3,088	3,599	4,503	17,999	5,025	36,465
Total general	10,783	14,504	17,265	23,207	80,178	24,420	170,357

Tabla: Afiliados por Curso de Vida y EPS – Zipaquirá (Fuente: BDUA, 2025)

A continuación se da a conocer la estructura del instrumento de adherencia a historia el cual está alineado con los lineamientos establecidos en la Resolución 3280 de 2018 (9), que define las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) como mecanismos para garantizar el derecho a la salud de manera integral, el instrumento fue diseñado para verificar el cumplimiento de las actividades clínicas, preventivas y promocionales que deben registrarse en la historia clínica de cada usuario, según su curso de vida por su ruta priorizada.

EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A HISTORIA CLÍNICA				
UNIDAD AMBULATORIA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO			
FECHA DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL	1	2	3	
EVALUACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA POR CURSO DE VIDA				
ASPECTO EVALUADO		PRIMERA INFANCIA (0-5 años)		
		0-5	FECHA	SEXO
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfil profesional encargado de la consulta de valoración integral	Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría o medicina familiar realizado en el mes: 4-5 meses, 12-18 meses, 24-29 meses, 3 años y 5 años.			
valoración de antecedentes y aspectos de enfoque diferencial	Atención en salud por profesional de enfermería en los: 2-3 meses, 6-8 meses, 9-11 meses, 18-23 meses, 30-35 meses y 4 años. valoración pertenencia grupos étnicos. valoración pertenencia grupos para enfoque diferencial migrante, víctima del conflicto armado discapacidad. Se verifica la realización de tamizajes neonatal, auditivo, errores innatos del metabolismo y cardiopatía. valoración de antecedentes neonatales: medicación, hospitalarios, transfusionales, farmacológicos. Valoración de antecedentes Personales. Exposición al humo del tabaco consumo de sustancias psicoactivas (padres). Se indaga frente a los progresos en hitos del desarrollo, entornos de educación, desarrollo del lenguaje. Se indaga frente a la alimentación del niño 0-6 meses. Verifica lactancia materna exclusiva. Se indaga frente a la alimentación del niño 6-18 meses. Frecuencia, alimentación, forma y tipo de. Se indaga por el establecimiento de rutinas y hábitos saludables. Se indaga acerca de prácticas de crianza y cuidado. Se indaga frente a la conformación y dinámica familiar. Valoración del contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.			
mantenimiento	Agudeza familiar: Indaga frente a la conformación del hogar y personas con las que habita. Aplicación de familiarograma. valoración del contexto social y redes de apoyo social y comunitario. Escucha. Valoración de pertenencia social y cultural. Exposición a violencia.			

CONTROL PRENATALPF.LACTANCIA MATERNAPRIMERA INFANCIAINFANCIAADOLESCENCIA

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Estructura del instrumento:

El archivo Excel contiene una matriz organizada por campos que permiten evaluar la adherencia a las RIAS en tres dimensiones: identificación del usuario, caracterización por ciclo de vida, y cumplimiento de intervenciones específicas.

1. Datos básicos del paciente

- Identificación, edad, sexo, EPS, fecha: estos campos permiten personalizar la evaluación y asegurar que las intervenciones estén contextualizadas según el perfil del usuario.

2. Clasificación por ciclo de vida

- El instrumento segmenta a los usuarios en seis grupos, conforme a la clasificación oficial:

Ciclo de vida	Rango de edad
Primera infancia	0 – 5 años 29 días
Infancia	6 – 11 años 29 días
Adolescencia	12 – 17 años 29 días
Juventud	18 – 28 años 29 días
Adultez	29 – 59 años 29 días
Vejez	60 años en adelante

Esta segmentación permite aplicar las rutas correspondientes y evaluar si las intervenciones fueron pertinentes y completas.

3. Ruta aplicada y tipo de intervención

Cada fila del instrumento indica la ruta priorizada (materno-perinatal o promoción y mantenimiento) y las actividades esperadas por etapa. Por ejemplo:

- Ruta materno-perinatal: consulta preconcepcional, control prenatal, planificación familiar.

- Consulta preconcepcional: examen físico, paraclínicos, antecedentes
- Control prenatal: antecedentes, examen físico, clasificación de riesgo
- Planificación familiar: antecedentes, educación, métodos ofertados, examen físico
- **Lactancia Materna:** examen físico, estado nutricional, cuidado de las mamas, alteraciones.
- **Primera infancia-infancia:** vacunación, control de crecimiento y desarrollo, tamizajes nutricionales.
- **Adolescencia:** valoración del desarrollo, alimentación, educación sexual, salud mental, prevención consumo de sustancias.
- **Juventud:** educación sexual, prevención de consumo de sustancias, salud mental.
- **Adultez:** control de hipertensión, diabetes, citologías, mamografías.
- **Vejez:** valoración funcional, prevención de caídas, seguimiento de enfermedades crónicas.

4. Criterios de cumplimiento

Cada actividad se evalúa con tres opciones:

- **Cumple:** la intervención está registrada y completa.
- **No Cumple:** la intervención está ausente o incompleta.
- **No Aplica:** la intervención no corresponde al perfil del usuario.

El instrumento esta parametrizado para calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento por historia clínica, permitiendo clasificar los resultados en rangos:

- Satisfactorio: 85 - 100%
- Aceptable: 70 - 84%
- Crítico: 50 - 69%
- Muy crítico: ≤ 50%

Explicación del cuadro según la evaluación de adherencia a Listas de Chequeo que aportan al acceso de las RIAS.

El instrumento de evaluación de lista de chequeo a atención integral en salud, tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los estándares definidos en las rutas de promoción y mantenimiento, con el fin de obtener adherencia a los proceso admirativos del prestador que interviene de manera notoria frente a la prestación de los servicios en salud, evitando barreras de acceso.

EVALUACION DE LISTA DE CHEQUEO ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL IPS						
UNIDAD AMBULATORIA		CRITERIOS DE CALIFICACION				
FECHA DE EVALUACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		
NOMBRE DEL PROFESIONAL		1	0.5	1		
		ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL IPS				
ASPECTO EVALUADO		CC	FECHA	EDAD	SEXO	
		CRITERIOS DE CALIFICACION				OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA		
Implementación de las RIAS (Violencia de género, Riesgo Suicidio, Consumo SPA, VCA, PcD (Involucrando ruta de certificación de discapacidad del municipio)	Protocolos de atención, diagramas de flujo, acciones desde la IPS y su implementación.					
Incorporar la variable PcD, VCA y poblaciones diferenciales en sus registros administrativos garantizando acceso oportuno a los servicios de salud. Clasificando los 7 tipos de discapacidades en las historias clínicas: física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial.	Verificar categorías de discapacidad en las Historias Clínicas diferenciales, categoría psicosocial.					

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Estructura del instrumento:

1. Identificación y caracterización del usuario

- **Campos incluidos:** Unidad ambulatoria, fecha de evaluación, nombre del profesional.
- Este campo determina qué ruta se aplica y qué estándares son relevantes para la evaluación.

2. Categorización de cumplimiento

Cada estándar se evalúa con una de las siguientes categorías:

Categoría	Significado
C (Cumple)	El estándar fue aplicado correctamente.
NC (No Cumple)	El estándar no fue aplicado o presenta fallas.
NA (No Aplica)	El estándar no corresponde al paciente por edad, condición o contexto.

3. Lista de chequeo según cursos de vida

- **Detección temprana CA cuello uterino:** descripción del procedimiento, procedimiento, resultados positivos citologías, educación en salud, control de muestras, verificación toma CCV y VPH/ADN, sistema de información.
- **Detección temprana CA próstata:** descripción del procedimiento, procedimiento, resultados, educación en salud, plan de cuidado, gestión, verificación para tamización mediante examen clínico, sistema de información.
- **Detección temprana CA mama:** descripción del procedimiento, examen clínico de mama, resultados mediante mamografía, educación en salud, gestión, verificación examen, sistema de información.
- **Detección temprana CA colon y recto:** descripción del procedimiento, procedimiento, resultados, educación en salud, plan de cuidado, gestión, verificación examen sangre oculta en heces, sistema de información.
- **Resolución 2350 de 2020:** detección e identificación casos de niños de 0 a 59 meses con desnutrición aguda, examen físico, tratamiento, egreso y seguimiento IPS, requerimientos esenciales, sistema de información.
- **Resolución 2465 de 2016:** adoptan los Indicadores Antropométricos, Patrones de Referencia y Puntos de Corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad.
- **Salud oral:** descripción del procedimiento administrativo del programa.
- **ITS-VIH:** atención integral implementación Plan Nacional VIH/ITS, promoción y prevención, atención integral en salud, verificación atención de ITS VIH SIDA, sistema de información.
- **Violencia sexual IPS:** atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, verificación y mantenimiento, recepción inmediata de la víctima de violencia sexual, sistema de información.
- **Salud mental:** implementación de las RIAS (Violencia de género, Riesgo Suicida, Consumo SPA, VCA, PcD (involucrando ruta de certificación de discapacidad del municipio), incorporar la variable PcD, VCA y poblaciones diferenciales en sus registros administrativos garantizando acceso oportuno a los servicios de salud, verificar la asignación oportuna de citas para los servicios de baja complejidad en la atención integral en salud mental, PcD, VCA y epilepsia de las personas dentro del municipio, porcentaje de personas con diagnóstico presuntivo que accedieron a exámenes especializados necesarios para su diagnóstico y tratamiento en salud mental y epilepsia incluyendo a la PVC, programas de detección precoz, servicios de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad, atención prioritaria.

4. Totales y cálculo de porcentajes

- **Total Cumple:** suma de los estándares marcados como “C”.
- **Total No Aplica:** suma de los estándares marcados como “NA”.

- **Total Evaluado:** total de estándares menos los “NA”.
- **Porcentaje de diligenciamiento:**

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{total cumple}}{\text{total evaluado}} \right) \times 100$$

Este indicador refleja el grado de cumplimiento efectivo de la ruta aplicada al paciente.

5. Ponderador

- Se tiene parametrizado cada componente , se asigna un **valor** para garantizar uniformidad en la medición.
- El ponderador permite calcular el impacto relativo de cada estándar dentro del total de la ruta.

6. Semaforización

- **Verde:** Porcentaje de diligenciamiento satisfactorio (usualmente $\geq 80\%$).
- **Rojo:** Porcentaje crítico o bajo cumplimiento (usualmente $< 80\%$).

Este sistema facilita la visualización rápida de los casos que requieren intervención o revisión.

Fase de seguimiento

La fase de seguimiento constituye un componente esencial dentro de la implementación de la estrategia RIAS, ya que permite verificar de manera continua el cumplimiento de las acciones de mejora que la IPS genera y garantiza la sostenibilidad de los procesos en el tiempo. Este debe ser sistemático, oportuno y basado en las evidencias, priorizando el análisis de resultados, permitiendo el ajuste a las intervenciones y articulándose con la evaluación final.



Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Metodología

La estrategia metodológica se fundamenta en un enfoque cuali-cuantitativo, orientado a fortalecer la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)(2) en el municipio de Zipaquirá. Este enfoque permite evaluar la adherencia técnica, operativa y documental de las IPS frente a los lineamientos establecidos en la Resolución 3280 de 2018 (9), con énfasis en la atención por curso de vida y el enfoque diferencial.

La metodología se articula con los objetivos de la meta 149(10) del Plan de desarrollo 2024-2027de la alcaldía de Zipaquirá y el plan Decenal de Salud Pública, priorizando la atención integral, continua y centrada en las personas

Es de suma importancia resaltar que durante esta segunda fase de seguimientos se deben tener encuentra estas alertas que si se llegan a presentar durante el acompañamiento se deben reportar a continuación se describen.

ALETAS ASISTENCIA TÉCNICA RIAS IPS

1. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA O SEVERA (RESOLUCIÓN 2350)

HALLAZGO	PRIORIDAD	ACCIÓN DE MEJORA IPS	TIEMPO NUEVO SEGUIMIENTO
Menor de 5 años reportado en MANGO con DNT Aguda modera o severa sin notificación en SIVIGILA – EVENTO 113	Alta	Programar un nuevo seguimiento al menor de 5 años para confirmar o descartar la desnutrición aguda. Si se confirma el diagnostico de desnutrición aguda se debe realizar notificación al SIVIGILA y activar la ruta de atención (Resolucion2350)	2 días calendario posterior al hallazgo se debe confirmar el diagnostico.
Menor que según valoración antropométrica se encuentre en desnutrición aguda moderada o severa sin notificación a SIVIGILA-Evento 113.	Alta	Programar un nuevo seguimiento al menor de 5 años para confirmar o descartar la desnutrición aguda. Si se confirma el diagnostico de desnutrición aguda se debe realizar notificación al SIVIGILA y activar la ruta de atención (Resolucion2350)	2 días calendario posterior al hallazgo se debe confirmar el diagnostico.
Menor de 5 años con DNT Aguda modera o severa sin seguimiento oportuno.	Alta	Programar seguimiento al menor de 5 años diagnosticado con DNT con nutrición o pediatría.	El mismo día del hallazgo se debe realizar asignación del seguimiento.
Disponibilidad de FTLC para la realización de prueba de apetito.	Media	IPS debe garantizar la disponibilidad de sobres de FTLC para la realización de prueba de apetito.	8 días calendario

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

2. RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD - (RESOLUCIÓN 3280 DE 2018)

CURSO DE VIDA	HALLAZGO	PRIORIDAD	ACCIÓN DE MEJORA IPS	TIEMPO NUEVO SEGUIMIENTO
Primera infancia	No se realiza la prescripción de los micronutrientes en polvo para los niños de 6 a 24 meses de edad	Media	Garantizar la prescripción de los micronutrientes en polvo para los niños de 6 a 24 meses de edad.	Un mes
Primera infancia	No cuenta con historia clínica diferencial para la consulta de consejería en lactancia materna.	Baja	Formato de historia clínica diferencial para la consulta de consejería en lactancia materna.	3 meses
Adultez Y vejez	CÁNCER DE MAMA: 1. Mujeres mayores de 40 años sin examen clínico de mama en el último año. (examen realizado por profesional en medicina o Enfermería entrenado en la IPS). 2. Mujeres mayores de 50 años, “que nunca se hayan tomado mamografía o lleven más de dos años sin toma”. CÁNCER DE CUELLO UTERINO: 1. Mujeres mayores de 25 años con vida sexual activa, teniendo en cuenta “que nunca se hayan tomado citología cervicouterina o lleven más de tres años sin toma” esquema 1- 3 - 3 ante resultados negativos. 2. Mujeres menores de 25 años de acuerdo con criterios y factores de riesgo como: Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, multiparidad 3 o más hijos, múltiples compañeros sexuales. 3. Mujeres entre 30 a 65 años que no se hayan realizado la Prueba Molecular de ADN VPH en el esquema de 1-5-5 ante resultados negativos. CÁNCER DE PRÓSTATA: 1. Hombres entre los 50 a 75 años teniendo en cuenta “que nunca se hayan tomado prueba de antígeno prostático y/o tacto rectal en los últimos cinco años o con factores de riesgo asociados cada dos años “.	Media	IPS debe garantizar la generación de la orden para el tamizaje, el agendamiento y la socialización de los resultados.	Un mes

Adultez	Mamografía, citología, PSA alterados	Alta	EPS debe garantizar el agendamiento y la toma del examen confirmatorio del diagnóstico según la tuta para cada caso	15 días
---------	--------------------------------------	------	---	---------

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

3. RESOLUCIÓN 2465 DE 2016

HALLAZGO	PRIORIDAD	ACCIÓN DE MEJORA IPS	TIEMPO NUEVO SEGUIMIENTO
No se cuenta con equipo antropométrico (pesa bebe, Infantometros, tallímetro o cinta métrica)	Alta	Garantizar todos los equipos antropométricos para la valoración nutricional.	8 días calendario
Equipo antropométrico (pesa bebe, Infantometros, tallímetro o cinta métrica) <u>dañado o descalibrado.</u>	Alta	Garantizar todos los equipos antropométricos para la valoración nutricional.	8 días calendario
No cuenta con certificado de calibración de los equipos.	Media	Garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos antropométricos.	Un mes

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

De igual manera durante esta fase es de suma importancia tener presente los alcances que debe tener cada líder RIAS, durante el acompañamiento del ejercicio en la IPS a continuación se relacionan.

Componente: Salud menta

COMPONENTE: Salud mental		
PROFESIONAL ENCARGADO: Psicólogo Equipo RIAS		
ALCANCE	ASPECTOS PARA EVALUAR	PRODUCTOS
Seguimiento al reporte a los sistemas de información.	1. Verificar los casos de los tres eventos de salud mental (Violencias, Conducta suicida y consumo SPA) que sean remitidos desde la secretaria de salud para identificar la atención oportuna, asignación de citas inicial y seguimiento. 2. Revisar reporte al SIVIGILA- Evento 875. 356 y 365: se debe verificar calidad del dato, ajustes o descarte de los eventos en los casos donde no cumpla con definición de caso o se identifique errores en la notificación. 3. Apoyar el proceso de notificación de la matriz P Y D correspondiente a los casos de victimas del conflicto armado identificados y atendidos por cada una de las IPS.	Acta de asistencia técnica donde se especifique hallazgos en la verificación de los 5 aspectos a evaluar y compromisos por parte de la IPS.
Seguimiento caso a caso del cumplimiento de las atenciones establecidas en la ruta integral de salud mental	4. Garantizar el cumplimiento de la ruta de atención para población víctima del conflicto armado donde se evidencia que la IPS oferta todas las atenciones establecidas por la norma. 5. Apoyar el proceso de identificación y notificación a la secretaria de salud de casos de epilepsia y trastornos mentales atendidos por la IPS.	Bases de datos de casos de epilepsia y trastornos mentales atendidos por la IPS.

Componente: Seguridad alimentaria y nutricional.

COMPONENTE: Seguridad Alimentaria y Nutricional		
PROFESIONAL ENCARGADO: Nutricionista Equipo RIAS		
ALCANCE	ASPECTOS PARA EVALUAR	PRODUCTOS
Seguimiento al reporte a los sistemas de información. Seguimiento caso a caso del cumplimiento de las atenciones establecidas en la ruta integral de atención menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa.	1. Verificar el envío de formato de Excel de carga masiva-MANGO con la información de las consultas de menores, adultos y gestantes al epidemiólogo de la Gobernación de Cundinamarca con copia a la referente de la Secretaria de Salud (vspnutricioncundinamarca@gmail.com y saludpu.prof9@zipaquirá.gov.co) 2. Revisar reporte al SIVIGILA- Evento 113: se debe verificar calidad del dato, ajustes o descarte de los eventos en los casos donde no cumpla con definición de caso o se identifique errores en la notificación. 3. Realizar revisión de historias clínicas de menores reportados en MANGO con desnutrición aguda que aún no han sido notificados al Evento 113, si el menor cumple con los criterios de definición del evento de acuerdo con el Protocolo de Vigilancia de Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años del Instituto Nacional de Salud se debe solicitar la notificación inmediata del menor a SIVIGILA - Evento 113 y hacer seguimiento a dicha solicitud hasta que se verifique que el menor aparece en las bases de SIVIGILA. Se debe establecer un plan de mejora con la UPGD para garantizar que todos los menores que cumplen con criterios para definición del evento 113 sean notificados de forma oportuna. Si el menor no cumple con criterios para definición del evento, hacer el respectivo reporte relacionando las razones por las que el menor no debe ser notificado al SIVIGILA con el evento 113. 4. Gestión de menores notificados con desnutrición sin seguimiento nutricional o con barreras de acceso para la entrega de la FTLC.	Acta de asistencia técnica donde se especifique hallazgos en la verificación de los 4 aspectos a evaluar y compromisos por parte de la IPS. Base de menores reportados en MANGO y SIVIGILA con desnutrición aguda retroalimentada con información de la últimas atención y observaciones según el caso.

Componente: Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles.

COMPONENTE: Vida Saludable y Condiciones no Trasmisibles		
PROFESIONAL ENCARGADO: Profesional en enfermería Equipo RIAS		
ALCANCE	ASPECTOS PARA EVALUAR	PRODUCTOS
Seguimiento al reporte a los sistemas de información. Seguimiento a la canalización efectiva de pacientes identificados con riesgo cardiovascular y metabólico.	1. Verificar el envío de Kardex de pacientes con enfermedades crónicas a la referente de la Secretaria de Salud (saludpu.prof9@zipaquirá.gov.co) 2. Entregar base de pacientes identificados con riesgo cardiovascular o metabólico a través de la estrategia Zipaquirá vive saludable. 3. Verificar la canalización efectiva por parte de la IPS de la población con riesgo cardiovascular canalizada. 4. Realizar la gestión de los casos donde se identifiquen barreras de acceso en la atención o en la entrega de medicamentos.	Acta de asistencia técnica donde se especifique hallazgos en la verificación de los 4 aspectos a evaluar y compromisos por parte de la IPS. Base de canalización retroalimentada con información de la últimas atención y observaciones según el caso.

Diseño metodológico

Instrumento Plan de mejora por parte de las IPS

Una vez finalizado el informe de resultados de la evaluación obtenida, cada IPS se dispone a diligenciar el formato de plan de mejora con sus respectivas intervenciones a trabajar con la finalidad de generar un análisis a las causas y sus acciones correctivas. Este plan debe abordar las brechas identificadas y proponer acciones concretas para fortalecer la implementación de las RIAS.

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

Fuente: Elaborado por Secretaría de Salud de Zipaquirá

ha sido completado.
enciados correctamente.
con respaldos periódicos.
d de los datos para futuras auditorías o

1. **Notificación al líder del equipo RIAS:** se informa que el registro ha sido completado.
2. **Verificación técnica:** se revisa que todos los campos estén diligenciados correctamente.
3. **Custodia digital:** la información se resguarda en entorno seguro con respaldos periódicos.

planes de mejora.
en los resultados

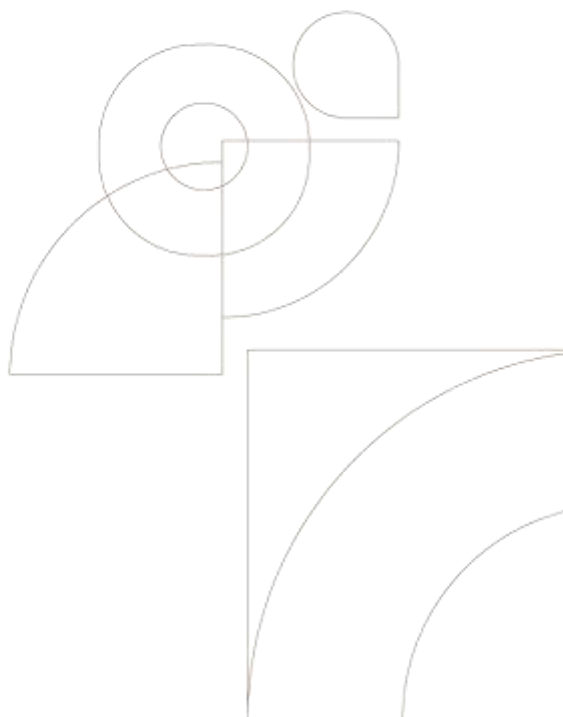
La Secretaría de Salud realizará evaluaciones periódicas para verificar el cumplimiento de los planes de mejora. Este ciclo de vigilancia no es estático, sino dinámico, permitiendo ajustar estrategias según los resultados obtenidos.

La implementación del instrumento de vigilancia busca:

- Garantizar atención integral, equitativa y de calidad.
- Mejorar los indicadores de salud pública.

- Fortalecer la articulación entre IPS, Secretaría de Salud y comunidad.
- Promover la mejora continua en la gestión territorial en salud.

La finalidad de la aplicación del instrumento de plan de mejora nos lleva a una atención justa, oportuna y de calidad en cada una de las rutas de atención en salud del municipio Zipaquirá. Logrando identificar las necesidades de los ciudadanos mediante un análisis sistemático, resultados en tiempo real y planes de mejora definidos. El éxito de este proceso de monitoreo y mejora continua dependerá en gran medida de la cooperación entre las IPS, la Secretaría de Salud y la comunidad.



SC-CER587218



Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Conclusiones y Recomendaciones

- ✚ Poner en marcha la estrategia RIAS, que está documentada en este manual, genera una vigilancia continua para la verificación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), ya que es un progreso importante para la secretaria de salud de Zipaquirá.
- ✚ Este proceso aportará a la continuidad y calidad de la atención en las IPS del municipio, facilitando la identificación oportuna de las brechas administrativas, clínicas y operativas, que los lleve a evidenciar las oportunidades de mejora, las cuales se trabajarán y se les realizará seguimiento continuo para mitigar los riesgos en salud de la población zipaquireña.
- ✚ El impacto que genera este proyecto llevar a los prestadores de salud a generar una alianza con la secretaria de salud del municipio que transformará de manera positiva la gestión del riesgo y la gestión clínica, logrado así el poder lograr el objetivo de la meta 149 del plan de desarrollo municipal que mantener la adherencia de las RIAS, en el municipio.

Recomendaciones para mantener la adherencia a las rutas integrales en salud.

A partir de las conclusiones del proceso de la estrategia RIAS, se sugieren las siguientes recomendaciones para optimizar la adherencia a las RIAS:

- ✚ Potenciar la capacitación técnica del personal de salud, en particular en lo que respecta al diligenciamiento de historias clínicas y a la aplicación de rutas por curso vital.
- ✚ Realizar ciclos de retroalimentación ininterrumpida entre las IPS y la Secretaría de Salud, con oportunidades para analizar los resultados en conjunto.
- ✚ Mantener actualizado las pirámides poblacionales con el fin de dar prioridad a las intervenciones en salud de acuerdo a los curso de vida.
- ✚ Consolidar la trazabilidad de las intervenciones realizadas durante el desarrollo de la estrategia RIAS en cada IPS.
- ✚ Poner en práctica planes de mejora que cuenten con cronogramas, responsables e indicadores claros para su seguimiento.

Visión a futuro en la salud pública local

En el municipio de Zipaquirá, la estrategia RIAS se ha consolidado como una experiencia metodológica replicable, con potencial de expansión hacia otros territorios del país. Su proyección a futuro contempla el fortalecimiento de un sistema de información territorial que articule procesos de vigilancia, evaluación y planificación, permitiendo una gestión más precisa y adaptada a las realidades locales. Esta visión también implica el desarrollo de una cultura institucional orientada a la mejora continua, sustentada en la evidencia técnica y en la corresponsabilidad entre los actores del sistema de salud. La participación activa de Los prestadores primarios en salud, se reconoce como un componente esencial, no solo en la validación de las rutas, sino en la construcción de soluciones contextualizadas que respondan a las necesidades reales de la población. Asimismo, se busca consolidar la capacidad resolutoria de las IPS para brindar atención integral según las exigencias de cada curso de vida, alineando los esfuerzos municipales con los objetivos nacionales en salud pública para garantizar calidad, equidad y sostenibilidad. Más que un instrumento de medición, se convierte en un agente transformador: dinámico, adaptable y profundamente vinculado al territorio y a la población zipaquireña.



SC-CER587218



Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co

Anexos

Cronograma RIAS 2025

Actividad	Responsable	Periodo	Observaciones
Diseño y planificación del instrumento	Equipo técnico Secretaría de Salud	Enero - Febrero 2025	Revisión normativa y definición de rutas prioritarias
Implementación piloto en IPS	Coordinadores PYD / IPS	Marzo - Abril 2025	Aplicación de listas de chequeo y revisión documental
Evaluación y de consolidación resultados	Equipo auditor	Mayo 2025	Informe preliminar y retroalimentación
Socialización de resultados con IPS-EPS	Secretaría de Salud	Junio 2025	Mesas de trabajo con actores locales
Plan de mejora institucional	IPS participantes	Julio 2025	Presentación de acciones correctivas en 5 días hábiles
Seguimiento y acompañamiento técnico	Secretaría de Salud / Líder RIAS	Agosto - Octubre 2025	Monitoreo y visitas de verificación
Cierre y evaluación final	Secretaría de Salud	Noviembre - Diciembre 2025	Informe final y propuestas de mejora continua

Glosario de términos

Adherencia

Cumplimiento de los lineamientos, protocolos y actividades definidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) por parte de las instituciones, profesionales y usuarios.(11)

Auditoría en Salud

Proceso sistemático y continuo de evaluación de la calidad, oportunidad y pertinencia de la atención en salud, mediante la verificación de estándares, registros clínicos e indicadores.(12)

Ciclo de Vida

Etapas en que se organiza la atención en salud según la Resolución 3280 de 2018: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez.(13)

Confidencialidad

Garantía de que la información en salud de los usuarios será protegida y utilizada únicamente para fines clínicos y de gestión autorizada, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.(14)

Curso de Vida

Perspectiva de análisis que orienta la planeación de intervenciones en salud de acuerdo con las necesidades específicas de cada etapa de desarrollo humano.(15)

Diagnóstico Situacional

Instrumento de análisis que identifica el estado de salud de una población, sus determinantes, riesgos y recursos disponibles, para orientar la planeación en salud.(16)

Historia Clínica

Documento privado, obligatorio y sometido a reserva, que contiene los datos, valoraciones, intervenciones y evolución del estado de salud de una persona, regulado por la Resolución 1995 de 1999.(4)

Indicadores de Evaluación

Medidas cuantitativas y cualitativas que permiten valorar el grado de cumplimiento, eficacia y eficiencia de las RIAS en la práctica institucional y territorial.(17)

IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud)

Organizaciones responsables de ofrecer servicios de atención en salud a los usuarios en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).(18)

Líder RIAS

Profesional designado en cada IPS o por la Secretaría de Salud para coordinar, implementar y supervisar el cumplimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud.(19)

Monitoreo

Proceso de seguimiento continuo que permite identificar avances, dificultades y resultados en la implementación de las RIAS.(19)

Plan de Mejora

Conjunto de acciones correctivas, preventivas y de fortalecimiento diseñadas por las IPS, derivadas de hallazgos en auditorías o seguimientos de la Secretaría de Salud.(20)

Resolución 3280 de 2018

Norma del Ministerio de Salud y Protección Social que define las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) como mecanismo obligatorio para garantizar la atención integral y continua en el curso de vida.(9)

RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud)

Esquema de organización de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación, que integra diferentes servicios y niveles de atención para garantizar la integralidad, continuidad y equidad en la atención en salud.(2)

Seguimiento

Actividad que verifica el cumplimiento de las acciones de mejora, los planes implementados por las IPS y la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo.(2)

SIGIRES

Sistema de información para la gestión y reporte de resultados en salud, utilizado para consolidar indicadores y verificar la adherencia a las RIAS en tiempo real.(21)

Bibliografía.

1. [adres.gov.co/eps/procesos/bdua](https://www.adres.gov.co/eps/procesos/bdua) [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.adres.gov.co/eps/procesos/bdua>
2. Rutas integrales de atención en salud - RIAS [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/paginas/rutas-integrales-de-atencion-en-salud-rias.aspx>
3. World Health Organization. Informe sobre la salud en el mundo 2008 : la atención primaria de salud, más necesaria que nunca. World Health Rep 2008 Prim Health Care More Ever. 2008;125.
4. Microsoft Word - Resolucion-Salud.dot [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/resoluci%C3%93n%201995%20de%201999.pdf
5. Ley 23 de 1981 - Gestor Normativo [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68760>
6. Política de Protección de Datos Personales - [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/>
7. 839 Modifica Resolucion 1995 de 1999 - Manejo Custodia Historias Clinicas [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No%20839%20de%202017.pdf
8. Microsoft Word - Decreto 1011 _3 Abril 2006_.doc [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto%201011%20de%202006.pdf
9. RESOLUCION 3280 DE 2018.pdf [Internet]. [citado 17 de marzo de 2025]. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%203280%20DE%202018.pdf>
10. 76808_acuerdo-02-completo.pdf [Internet]. [citado 25 de agosto de 2025]. Disponible en: https://zipaquiracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/zipaquiracundinamarca/content/files/001537/76808_acuerdo-02-completo.pdf
11. <https://www.cun.es> [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Adherencia: qué es y definición médica | Diccionario CUN. Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/adherencia>
12. Páginas - Auditoría para el mejoramiento de la calidad [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/auditoria-para-el-mejoramiento-de-la-calidad.aspx>
13. Páginas - Ciclo de Vida [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/paginas/ciclovida.aspx>
14. Ley 1581 de 2012 - Gestor Normativo [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
15. ABCenfoqueCV.pdf [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ABCenfoqueCV.pdf>
16. Análisis de Situación de Salud (ASIS) [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/paginas/analisis-de-situacion-de-salud-.aspx>
17. Fonseca A, Rozo P, Montañó JI. Sistema Estándar de Indicadores Básicos en Salud.
18. Diapositiva 1 [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Funcionamiento%20Sector%20salud.pdf>

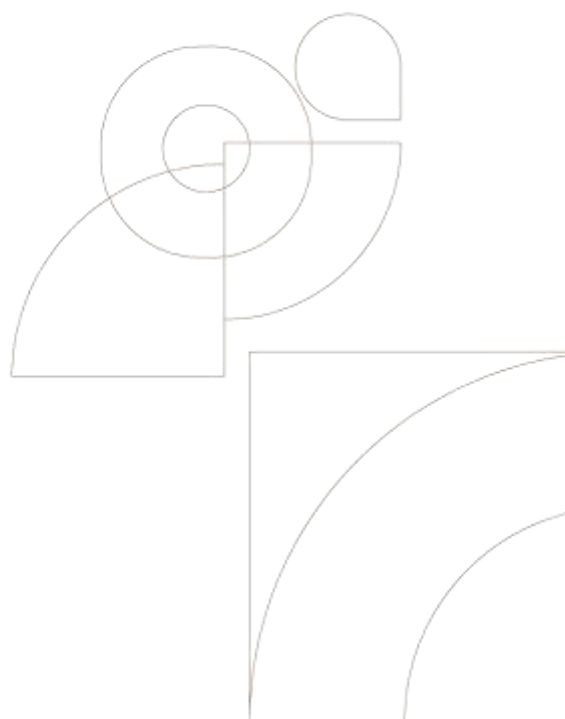


SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquiracundinamarca.gov.co



19. Rutas integrales de atención en salud - RIAS [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/paginas/rutas-integrales-de-atencion-en-salud-rias.aspx>
20. Microsoft Word - ABC DE PLANES DE MEJORAMIENTO.doc [Internet]. [citado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-elaboracion-planos-mejoramiento-acreditacion.pdf>
21. 202 Modifica el articulo 10 de la resolucion 4505 de 2012 y sustituye si anexo técnico - Ruta Integral de Atencion [Internet]. [citado 22 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20202%20de%202021.pdf



SC-CER587218

Dirección: Calle 4ª #17-02 Algarra III
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 320 979 4213
Código Postal: 250252
secretariadesalud@zipaquirá-cundinamarca.gov.co